SDD 161 Sujet n°2

Spécialité : Cardiologie

Date : 11/04/2024
Auteur : Redwane RAKZA (DES Cardiologie - ECN 2021)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (EDN 2024 MAR Toulouse)

Domaine d'apprentissage principal	Interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	
Item(s) en lien avec la station	Item 230 - Douleur thoracique aigue Item 235 - Péricardite
Situation(s) de départ en lien avec la station	Douleur thoracique
Matériel nécessaire à la station	1 table, 2 chaises
Contexte de la station	

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne aux services des Urgences.
Vous recevez Monsieur Lucas LEJEUNE, âgé de 26 ans qui se présente pour douleur thoracique.
L'infirmier d'accueil a réalisé un premier bilan qui retrouve les constantes suivantes : TA 124/76 mmHg, Fc 88 bpm, SpO2 100%, Température 37.1°C

Vous voyez sur l'ECG réalisé à l'entrée aux Urgences que le rythme est sinusal avec un sus-décalage concave du segment ST sur l'ensemble des dérivations.

Consignes :
Vous devez réaliser en 8 minutes:
- interroger le patient
- réaliser l'examen clinique à l'oral
- poser le diagnostic principal.

Vous ne devez pas :
- Vous ne devez pas prescrire d'examen complémentaire ou traitement

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)	
Récuperer les antécédents	
Recherche les antécédents cardiovasculaires personnels ET familiaux	1 pt
Rechercher au minimum 3 des facteurs de risque dans la liste suivante : OH, tabac, obésité, dyslipidémie, HTA	1pt
Évaluer une douleur thoracique	
Questionne la localisation et les irradiations de la douleur thoracique	1pt
Quantifie la douleur sur une échelle numérique (de 1 à 10 par exemple)	1pt
Questionne la temporalité de la douleur (date de début ou évolution)	1pt
Recherche l'existence de positions ou mouvements modifiant la douleur	1pt
Demander s'il y a eu des signes d'infection récente (syndrome grippal)	1pt
réalise l'examen cardiaque en énonçant les 4 foyers d'auscultation : aortique, pulmonaire, mitral, tricuspide	1pt
Recherche des frottement péricardique ou une diminution des bruits du coeur	1pt
Réaliser une auscultation pulmonaire	1pt
Poser le diagnostic	
Poser le diagnostic de péricardite	1pt
Précise qu'elle est aiguë	1pt
Communications et attitudes	

Aptitude à écouter

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

Aptitude à interroger

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

Aptitude à structurer, mener l'entrevue

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

<u>Éléments de rétroaction :</u>

Devant une suspicion de péricardite il faut réunir les éléments nécessaire au diagnostic

- Examen fonctionnel : présence d'une douleur thoracique intense réduite à l'antéflexion, souvent accompagnée de signes viraux actuels ou récents
- Examen clinique (frottement péricardique), rare mais typique
- ECG : ici on décrit bien une modification typique du segment ST
- Echocardiographie, n'étant pas utile ici au diagnostic

Cependant il faut rester prudent devant toute douleur thoracique et rester SYSTÉMATIQUE : il n'est pas acceptable d'oublier de refaire le point sur les facteurs de risques et antécédents cardiovasculaires.
L'interrogatoire plus que l'examen clinique est la clé dans la douleur thoracique.

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Plan de la station ECOS :

Patient assis sur une chaise de l'autre côté du bureau

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

J'ai mal dans la poitrine

Identité du patient :

Homme de 26 ans, 78kg pour 181 cm

Mode de vie :

Ingénieur informaticien, sportif, fumeur actif (1 paquet par jour depuis l'âge de 17 ans), alcool festif non quotidien, pas d'allergies connues.
Une conjointe actuellement en étude de droit. Rapports sexuels protégés.
Pas de voyage à l'étranger récent.

Comportement global :

Patient anxieux, se tient la poitrine, avec le torse penché vers l'avant.
La respiration est limitée par la douleur.

Antécédents personnels :

Aucun

Antécédents familiaux :

Infarctus chez son père à l'âge de 51 ans

Médicaments :

Traitement de fond : aucun Traitement pris dans le cadre de la situation clinique : PARACETAMOL à la maison Sans aucune efficacité

Symptômes positifs :

Si le candidat interroge les douleurs (ne répondre qu'à la question) :

- **Sur la douleur thoracique**
  - localisation : dans la poitrine, pas d'autres douleurs actuellement
  - type : Comme si j'avais une barre qui appuie sur la poitrine
  - temporalité : douleur permanente, qui fluctue mais toujours présente
  - date de début : débuté depuis 3 jours
  - évolution : aggravation progressive depuis l'apparition
  - aggravé/amélioré: douleur aggravé par l'inspiration profonde, mais franchement amélioré par le fait de se tenir penché en avant, non modifié par l'activité physique
  - antécédent : je n'ai jamais eu ce type de douleur auparavant

Si le candidat interroge d'autres symptômes actuel ou récents (hors douleurs)

- pas de palpitations
- pas de difficulté à respirer
- pas de perte de connaissance

Si le candidat interroge sur **les évènement récents**

- sport/loisir : pas d'activité physique intense récente, pas de fêle, pas de drogues
- fièvre, infection, syndrome grippaux récent, diarrhée ? : j'ai eu des crampes et des douleurs articulaires il y a 5-6 jours, mais maintenant ça va mieux,

ma chérie a eu les mêmes symptômes mais sans la douleur dans la poitrine, elle va mieux.
- traitement : j'ai pris du paracétamol hier et aujourd'hui (1 gramme 3 fois par jours) mais sans amélioration

Concernant l'examen clinique (sans particularité)

- auscultation cardiaque : sans anomalies
- auscultation pulmonaire : sans anomalie
- palpation thoracique : ne reproduit pas la douleur

Constantes :

TA 124/76 mmHg, Fc 88 bpm, SpO2 100%, Température 38.1°C

Donnée complémentaire :

ECG réalisé à l'entrée aux Urgences : rythme sinusal avec un sus-décalage concave du segment ST sur l'ensemble des dérivations.

Questions de relance :

Questions à poser au candidat médecin en cas de moment dans l'entretien, à partir de 6 minutes d'épreuve : - « Qu'est-ce que j'ai docteur ? »

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Où se positionne le/les patients, étudiant, le matériel

Matériel nécessaire à la station :

- *IPAD pour examinateur*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

Documents présents dans la station :

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*